

AFMCP 폐강 메시지 (Closing Remarks)

IFM 교수진 복수 (Dr. David Haase, Dr. Liz Boham, Dr. Bryan Stepanenko 등) | AFMCP 과정 완료 축하

1. 기능의학 여정의 시작 — 첫 번째 단계

- 기능의학 프레임워크는 환자 건강을 진정으로 변화시킬 수 있는 시스템 — 환자뿐 아니라 임상 의사의 자신도 변화
- 처음엔 정보 과부하로 혼란스럽지만, 실제 임상에 적용하면 기초적 생활습관 변화만으로도 환자가 좋아지는 경험
- 타임라인이 근본 원인을 드러내고, 환자를 바라보는 방식을 바꿈 → 흥분과 호기심이 돌아옴

2. 매트릭스 모델 활용 — "생각하고 연결하기"

- 매트릭스 모델을 생각의 플랫폼으로 활용: ATM(항원·트리거·매개인자), 임상 불균형, 수정 가능한 생활습관 요인, 타임라인
- 핵심: "레버리지 포인트가 무엇인가?" — 이 사람이 더 필요한 것, 덜 필요한 것, 포기할 수 있는 것, 얻어야 할 것
- 빅 픽처: 세부 내용보다 "생각하고 연결하고, 평가하고, 레버리지 포인트 찾기"

3. 치유의 4단계 정의

- ① 신뢰·협력적 관계 수립 → ② 공유된 이해 달성 → ③ 의식(ritual) 합의 및 실행 → ④ 안녕 상태 향상
- 첫 2단계(신뢰+공유된 이해)가 빠르게 형성되는 환자가 기능의학 시작하기 좋은 환자
- 치유는 신체·정신·감정·영적·사회·재정적 모든 영역에서 가능

4. 실천적 조언들

- 한 번에 모든 것을 적용하려 하지 말고, 처음 기능医학을 하게 된 동기에 부합하는 한 가지부터 시작
- "염증은 어디서든 거의 장에서 시작된다 — 장부터 시작하면 틀리지 않는다"
- 단순 메시지: "잘 먹고, 잘 자고, 잘 움직이고, 잘 배설해야 건강하다"
- 3P 원칙: Partnership(파트너십)·Participation(참여)·Power/Empowerment(권한 부여)
- 환자가 무엇이 잘못된지 알고 싶어 오는 것이 아니라, 무엇이 중요한지를 알고 싶어 온다 — "what matters"
- 간디 인용: "자신을 발견하는 가장 좋은 방법은 타인의 서비스 안에서 자신을 잃는 것"